3.2.5.2. 정신건강의학과 격리 및 강박

제 정 일	2014.10.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	정신건강의학과, 소아정신과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.2.5 신체보호대 및 격리·강박 4주기 정신의료기관평가기준: 3.2.2 격리, 3.2.3 강박 JCI Standard 7th Edition: COP.3

제1조 (목적)

1. 정신건강의학과, 소아정신과 환자의 권리, 존엄성 및 안전과 안녕을 위해 격리 및 강박 조치가 부적절하게 사용되는 것을 막고, 임상적으로 꼭 필요하다고 판단되는 상황에서만 제한적으로 사용될 수 있도록 적절한 진료지침 및 절차를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 격리(Seclusion): 입원 환자치료의 일환으로 환자가 응급상황(자해, 타해 또는 심한 손상을 초래할 수 있는 상황)으로 진행되는 것을 방지하기 위한 치료 또는 임상적인 상태의 조절을 위하여 제한된 공간에서 일정 시간 동안 행동을 제한하는 것을 말한다.
2. 강박(Restraint): 환자 또는 타인을 상해로부터 보호하기 위해 수동적 방법, 신체보호대 등 물리적 장치 및 기구 등을 사용하여 전신 혹은 신체의 일부분의 움직임을 제한하는 것을 말한다.

제3조 (절차)

1. 대상: 정신건강의학과/소아정신과 입원환자

2. 격리·강박 시행 기준
   1) 원칙
      (1) 다른 치료적 접근/전략을 사용할 수 있는지 검토하고, 다른 대안의 사용이 불가능하거나 실패한 경우 적용한다.
      (2) 최소한의 시간 동안 시행하고 격리 및 강박 시행 사유가 해소된 경우 중단한다.
   2) 기준
      (1) 자살 또는 자해의 위험이 높은 환자
      (2) 폭력성이 높아 다른 사람을 해할 위험이 높은 환자
      (3) 정신적·신체적으로 환자 스스로의 건강을 심각하게 해할 우려가 높은 환자
      (4) 기물파손 등 병동 환경을 심각하게 훼손할 가능성이 높은 환자
      (5) 질병과 관련하여 지나친 자극을 줄여 자·타해 위험성을 감소시킬 필요가 높은 환자
      (6) 환자가 스스로 충동을 조절할 수 없다고 느껴 격리, 강박을 요구하는 환자

3. 강박 도구 종류 및 관리 방법
   1) 종류: 신체보호대(손보호대, 사지보호대 등)에 의한 강박 등
   2) 시행방법: [부록1. 간호국 특수간호기술 매뉴얼-강박환자 간호]를 따른다.
   3) 강박 도구 관리 방법
      (1) 환자의 신체손상을 방지할 수 있는 안전한 재질(면소재 혹은 자석 억제대)의 강박 도구를 사용한다.
      (2) 강박 도구는 매 환자마다 세탁이 완료된 억제대를 사용하며 사용 중 오염되었을 경우 새것으로 교체한다.

4. 격리·강박 시행 절차
   1) 정신건강의학과 전문의의 지시
      (1) 격리 및 강박의 적용은 전문의 지시 하에 의사의 처방에 따라 시행하고 해제한다.
      (2) 의사는 지속적으로 격리 및 강박 적용이 필요하다고 판단되는 경우 적용 시마다 처방한다.
      (3) 격리 및 강박 시행 후 환자의 증상, 행동 조절 및 안정을 위하여 의사의 처방에 따라 약물을 투여할 수 있다.
   2) 설명 및 동의: 격리·강박 적용 전 환자 또는 보호의무자에게 적용사유 및 적용방법 등에 대해 설명하고 동의서를 받으며 불가피한 경우 적용 후 설명하고 동의서를 받는다.
   3) 공간: 병동에 안정실에서 시행한다. 안정실은 안전을 위해 산소 공급 코크나 흡입 코크 장치 등, 무엇인가를 걸 수 있는 구조물이 벽에 없어야 하며, 벽은 쿠션 장치가 되어 있어야 한다. 안정실은 안전상의 위험요소가 있지 않은지 격리·강박 전 혹은 후에 그리고 수시로 점검한다. 예외적인 상황인 경우(예, 초고령 환자, 보호자 동반 등)에는 의료진의 판단과 보호자 동의 하에 1인실에서 시행할 수 있다.
   4) 수행 직원: 환자 및 직원의 상해를 방지하기 위해 의료인(의사, 간호사) 포함 최소 2명 이상의 훈련된 직원들이 수행한다.
   5) 시행시간
      (1) 격리·강박의 1회 처방 최대 허용시간
         ① 성인: 격리 12시간, 강박 4시간 이하
         ② 19세 미만: 격리 6시간, 강박 2시간 이하
      (2) 격리·강박의 처방은 전문의의 평가에 의해 연장할 수 있으나 1회 최대 허용시간의 2배수의 시간을 넘기지 않는다. 즉, 성인 기준 격리는 연속 24시간, 강박은 연속 8시간을 초과하여 시행하지 않는다.
      (3) 단, 위험성이 뚜렷하게 높아 연속 최대 허용시간을 초과하여 격리나 강박이 필요한 경우 정신건강의학과 전문의의 대면평가를 거쳐 추가로 연장할 수 있다. 이 경우 다학제평가팀의 사후회의를 통해 해당 격리·강박 과정의 적합성을 검토하고 이를 별도의 회의록에 기록하여 보관한다.
      (4) 다학제평가팀
         ① 다학제팀의 주요 안건은 격리·강박 과정에 대한 사후적합성 검토이며, 필요 시 격리·강박 관리 사항에 대하여 논의할 수 있다.
         ② 구성: 위원장 1명(임상과장), 부위원장 1명(교수), 위원 3명(의국장, 병동파트장,

사회사업사) 등 5명의 운영위원으로 구성된다.

③ 회의는 위험성이 뚜렷하게 높아 격리·강박에 대한 최대 허용시간(1회 최대 허용시간의 2배수)을 초과하여 격리나 강박을 시행한 경우 사후에 진행한다.

④ 회의의 개회는 환자의 진료 과정에 참여하거나 관찰할 수 있는 의료진을 포함하여 환자의 보호자가 요청할 수 있으며 위원장은 이에 따라 회의를 개회한다.

6) 격리 및 강박을 시행할 시 아래 내용을 격리·강박 기록지에 작성하도록 한다.

(1) 시행일시, 지시자 및 수행자의 이름과 서명, 참여자명

(2) 해제일시, 지시자 및 수행자의 이름과 서명, 참여자명

(3) 격리·강박이 필요한 이유

(4) 격리·강박이 필요한 구체적 상황(필요시 기재)

(5) 격리·강박 모니터링

(6) 격리·강박 연장 시 이유 및 지시자, 수행자, 시행 및 해제 시간

7) 모니터링

(1) 격리

① 의료진은 최초 15분 이내 방문하여 직접 환자의 정신적, 신체적 상태, 위험행동 여부를 관찰하고 1시간마다 관찰 및 평가를 시행한다. (단, 진정약물을 투여했을 경우 최초 5분 이내 활력징후를 평가)

(2) 강박

① 의료진은 최초 15분 이내 방문하여 직접 환자의 정신적, 신체적 상태를 관찰하고 30분마다 관찰 및 평가를 시행한다. (단, 진정약물을 투여했을 경우 최초 5분 이내 활력징후를 평가)

② 신체보호대 적용 시 적용한 부위의 사지감각, 피부색, 피부온도와 움직임을 평가하여 기록하고 이후 1시간마다 사지감각, 피부색, 피부온도와 움직임, 활력징후, 자세, 활동, 외상, 위험행동 여부를 평가하여 기록한다.

(3) 격리·강박 중 환자의 상태를 모니터를 통해 수시로 확인한다.

8) 부작용 발생 예방을 위한 활동

(1) 안전한 환경을 유지한다.

(2) 필요 시 ADL (Activities of Daily Living)을 보조한다.

(3) 2시간마다 강박을 풀고 사지운동을 시켜주고, 필요 시 자세를 변경한다.

(4) 신체보호대 적용 시 적용 부위 피부간호를 시행한다.

9) 부작용 발생 시 중재 방법: 격리 및 강박 관련 피부손상, 근골격계 이상, 기타 이상 증상 등의 부작용 발생 시 의사에게 알리고 적절한 중재를 적용한다.

5. 격리·강박 해제

1) 격리나 강박은 가능한 최소한의 시간 동안 시행되는 것이 바람직하므로 격리·강박 사유가 해소된 것으로 평가되면 빠른 시간 내에 해제한다.

2) 다음의 경우 의사의 처방에 따라 격리·강박을 해제한 후 해제 이유를 환자 또는 보호의무자에게 설명하고 환자의 상태를 평가한다.

(1) 환자 상태가 안정되어 위험성이 없어진 경우

(2) 환자 스스로 충동을 조절할 수 없다고 느껴 환자의 요구로 격리 또는 강박을 적용한

경우 환자의 해지 요구 시

6. 관련 의료진은 격리 및 강박에 대해 신입직원 부서 오리엔테이션 시, 이후 연 1회 이상 교육을 받는다.

제4조 (부록)

1. 간호국 특수간호기술 매뉴얼-강박환자 간호

제5조 (참고)

1. 격리 및 강박 지침 2019.03 (보건복지부, 대한신경정신의학회)
2. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률
3. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행규칙 제51조
4. 2022년 정신건강사업안내 격리 및 강박 지침
5. Synopsis of Psychiatry, ninth edition, Benjamin James Sadock, Lippincott Williams & Wilkins, 2003
6. Psychiatric Mental Health Nursing, seventh edition, Mary C. Townsend ,F.Adavis company, 2012

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 10월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)